

Matczyna rana w aspekcie klinicznym

Pojęcie „**matczynej rany**” bywa używane w psychoterapii i literaturze popularnej jako opis bólu wynikającego z chronicznego braku emocjonalnej dostępności, akceptacji, ochrony lub przewidywalnej obecności matki. Z perspektywy naukowej nie jest to odrębna jednostka diagnostyczna, lecz raczej **opisowy skrót** dla zjawisk lepiej operacjonalizowanych jako: zaniedbanie emocjonalne, trauma relacyjna, niepewne lub zdeorganizowane przywiązanie, PTSD/CPTSD, depresja, lęk, trudności w regulacji emocji i zaburzenia funkcjonowania interpersonalnego. Klinicznie ważniejsze od samej etykiety jest więc precyzyjne rozpoznanie **jakiego rodzaju deficyt opieki wystąpił**, w jakim wieku, jak długo trwał i jakie pozostawił następstwa. [1]

Najmocniejsze dowody pokazują, że **emocjonalne zaniedbanie i szersze formy maltretowania w dzieciństwie** są powiązane z wyższym ryzykiem depresji, lęku, gorszego funkcjonowania w związkach, większej aleksytymii, większej wrażliwości na odrzucenie oraz częstszego rozwoju niepewnych wzorców przywiązania. Niedostępność matki jest jednym z możliwych źródeł tego wzorca, ale nie jedynym: równie ważne bywają depresja matki, jej własna trauma, ubóstwo, przemoc domowa, uzależnienia, chaos rodzinny, parentyfikacja, rozłąka, instytucjonalizacja i brak alternatywnego bezpiecznego opiekuna. Jednocześnie dane pokazują, że **nie chodzi wyłącznie o „matkę” jako taką, lecz o jakość opieki**: w metaanalizach zarówno wrażliwość matek, jak i ojców wiąże się z bezpieczeństwem przywiązania dziecka. [2]

Mechanizm szkody obejmuje kilka poziomów jednocześnie. Psychologicznie wczesna niedostępność opieki kształtuje **wewnętrzne modele robocze** typu „ja jestem niewarte opieki / inni są nieprzewidywalni”, sprzyja strategiom hiperaktywacji lub deaktywacji systemu przywiązania, aleksytymii, dysocjacji i trwałym trudnościom w przetwarzaniu emocji. Neurobiologicznie badania wiążą wczesne zaniedbanie i depryzację z zaburzeniami rozwoju kory przedczołowej, układu limbicznego, istoty białej oraz osi HPA; wyniki dla kortyzolu są jednak **heterogeniczne** i zależne od wieku, rodzaju ekspozycji, przewlekłości i czasu pomiaru. [3]

Najbardziej praktyczny wniosek terapeutyczny jest taki, że leczenie powinno być **sformułowane problemowo i fazowo**, a nie wokół samego hasła „matczynej rany”. Najlepsze poparcie mają psychoterapie ukierunkowane na traumę i przywiązanie w sensie funkcjonalnym: trauma-focused CBT/CPT/PE, EMDR, w przypadkach przewlekłych wzorców także terapia schematów; interwencje

„attachment-informed” są klinicznie sensowne, ale jako odrębna, jednorodna metoda u dorosłych mają słabszą bazę dowodową. Farmakoterapia bywa zasadna nie dla „rany” samej w sobie, lecz dla współistniejącej depresji, PTSD, lęku, bezsenności czy ciężkiej dysregulacji. [4]

Ramy pojęciowe i przyczyny

W praktyce klinicznej pojęcie „matczynej rany” warto rozumieć nie jako pojedynczy uraz, lecz jako **konstelację doświadczeń relacyjnych**, w których dziecko przez dłuższy czas nie otrzymuje od głównej figury opieki wystarczającego ukojenia, uznania emocji, ochrony, przewidywalności i wsparcia w regulacji pobudzenia. Polski przegląd o traumie relacyjnej opisuje takie doświadczenia jako prowadzące do pozabezpiecznych stylów przywiązania, nasilonego lęku, wstydu, poczucia winy i „zamrożenia emocjonalnego”. W ICD-11 najbliższymi formalnymi kategoriami są m.in. **reactive attachment disorder** w dzieciństwie oraz **complex PTSD** u starszych pacjentów, ale to nie są synonimy „matczynej rany”; to po prostu diagnostyczne ramy dla części jej możliwych następstw. [5]

Kluczowe jest również uniknięcie błędu **maternalnego esencjalizmu**. Dane rozwojowe wskazują, że determinantą bezpieczeństwa przywiązania jest przede wszystkim **wrażliwość i responsywność opiekuna**, a nie sama jego płeć czy biologiczny status. Nowsza metaanaliza wykazała podobne związki między bezpieczeństwem przywiązania dziecka a wrażliwością zarówno matek, jak i ojców. Oznacza to, że szkoda może wynikać z braku dobrze dostrojonego opiekuna w ogóle, a część ryzyka może być amortyzowana przez obecność innej bezpiecznej osoby dorosłej lub poprawę jakości opieki. [6]

Przyczyny mają zwykle charakter **biograficzny, rodzinny i społeczny jednocześnie**, a nie linearny. Najczęstsze udokumentowane czynniki ryzyka obejmują zaburzenia psychiczne rodzica, używanie substancji, przemoc partnerską, ubóstwo, przeciążenie opiekuńcze, samotne rodzicielstwo bez wsparcia, historię własnej traumy rodzica oraz formy społecznej deprivacji. Ubogie lub chaotyczne środowisko nie determinuje szkody automatycznie, ale zwiększa prawdopodobieństwo mniej przewidywalnej, mniej czulej i bardziej reaktywnej opieki. [7]

Szczególnie dobrze opisanym mechanizmem jest **depresja matki**. Przeglądy pokazują, że nieleczona depresja okołoporodowa i późniejsza depresja matek wiążą się z gorszym rozwojem społeczno-emocjonalnym dzieci, słabszą jakością interakcji i większym ryzykiem pozabezpiecznych lub zdeorganizowanych wzorców przywiązania; trzeba jednak pamiętać, że zależność ta bywa

moderowana przez wsparcie społeczne, udział drugiego opiekuna i ogólny klimat rodzinny. [8]

W praktyce przydatne jest rozróżnienie między **nieobecnością fizyczną** a **nieobecnością emocjonalną**. Dziecko może mieć matkę stale obecną fizycznie, ale niedostępną emocjonalnie z powodu depresji, traumy, uzależnienia, przemocy lub przewlekłego przeciążenia. Dla rozwoju systemu przywiązania sama obecność fizyczna nie wystarcza, jeżeli nie towarzyszy jej odpowiedź na sygnały dziecka i pomoc w organizowaniu stanów emocjonalnych. [9]

Poniższa tabela porządkuje najważniejsze grupy przyczyn.

Obszar	Typowe czynniki	Kliniczny sens
Biograficzny	rozłąka, hospitalizacja, śmierć, migracja zarobkowa, adopcja po wczesnej deprywacji, instytucjonalizacja	większe ryzyko zakłócenia ciągłości opieki i bezpieczeństwa bazy relacyjnej [10]
Rodzinny	depresja matki, PTSD rodzica, uzależnienia, przemoc partnerska, chaos, parentyfikacja, mała responsywność emocjonalna	wyższe ryzyko zaniedbania emocjonalnego i niepewnego przywiązania [11]
Międzypokoleniowy	własna trauma matki lub ojca, nieprzepracowane wzorce przywiązania, słaba mentalizacja rodzicielska	zwiększone ryzyko transmisji stylu opieki i psychopatologii do kolejnego pokolenia [12]
Społeczny	ubóstwo, niestabilność mieszkaniowa, dyskryminacja, brak wsparcia społecznego, izolacja	czynniki te nie są tożsame z zaniedbaniami, ale zwiększają jego prawdopodobieństwo i przewlekłość [13]

Mechanizmy psychologiczne

Teoria przywiązania zakłada, że powtarzalny sposób reagowania opiekuna na sygnały dziecka buduje **wewnętrzne modele robocze** dotyczące siebie, innych i relacji. W środowisku wspierającym dziecko uczy się, że cierpienie można regulować w relacji; w środowisku chłodnym, krytycznym lub nieprzewidywalnym dziecko może dojść do wniosków typu „moje potrzeby są kłopotem”, „na bliskości nie można polegać”, „miłość warunkowa jest jedyną dostępną miłością”. Te reprezentacje są częściowo stabilne i wpływają później na wybór partnerów, oczekiwania wobec bliskości, interpretację odrzucenia i zachowania autoprotekcyjne. [14]

Badania nad następstwami maltretowania dzieciństwa konsekwentnie pokazują związek z **niepewnym przywiązaniem w dorosłości**. Najnowsza trójpoziomowa metaanaliza raportowała dodatnie korelacje między maltretowaniem w dzieciństwie, a przywiązaniem lękowym oraz unikającym, odpowiednio około $r = 0,23$ i $r = 0,20$, przy czym związki były silniejsze dla maltretowania emocjonalnego. Dodatkowo przegląd i analiza mediacji wskazują, że zwłaszcza **lęk przywiazaniowy** pośredniczy między zaniedbaniem, a późniejszą psychopatologią. [15]

W sferze regulacji emocji najważniejszy jest podział na strategie **hiperaktywujące** i **dezaktywujące** system przywiązania. U osób bardziej lękowych dominują zwykle nadmierne poszukiwanie potwierdzenia, katastrofizacja odrzucenia, ruminacje i intensyfikacja sygnałów cierpienia. U osób unikających częstsze są tłumienie, dystansowanie, zaprzeczanie zależności, osłabianie kontaktu z własnym afektem i pozorna samowystarczalność. Nowsze przeglądy łączą style unikające z deaktywacją i tłumieniem, a style lękowe z hiperaktywacją i większym użyciem mniej dojrzałych obron, takich jak projekcja, dewaluacja czy rozszczepianie. [16]

Z perspektywy klinicznej ważne jest, że przewlekłe **zaniedbanie emocjonalne** częściej zaburza nie tylko ekspresję emocji, ale także ich rozpoznawanie i symbolizację. Metaanaliza obejmująca ponad 36 tys. osób wykazała dodatni związek między maltretowaniem w dzieciństwie a dorosłą aleksytymią na poziomie około $r = 0,23$. Aleksytymia i trudności regulacyjne działają następnie jako mechanizmy transdiagnostyczne, zwiększające ryzyko depresji, lęku, samouszkodzeń, dysocjacji i trudności w relacjach. [17]

W sytuacjach przewlekłego relacyjnego zagrożenia część dzieci rozwija **dysocjację** jako obronę przed nierozwiązywalnym konfliktem: osoba, która ma szukać ukojenia u opiekuna, doświadcza jednocześnie od tego samego opiekuna lęku, zawstydzenia lub emocjonalnego opuszczenia. Przeglądy pokazują, że przywiązanie zdeorganizowane i doświadczenia interpersonalnej traumy są powiązane z późniejszą dysocjacją, fragmentacją narracji autobiograficznej oraz trudnościami w integracji obrazu siebie. [18]

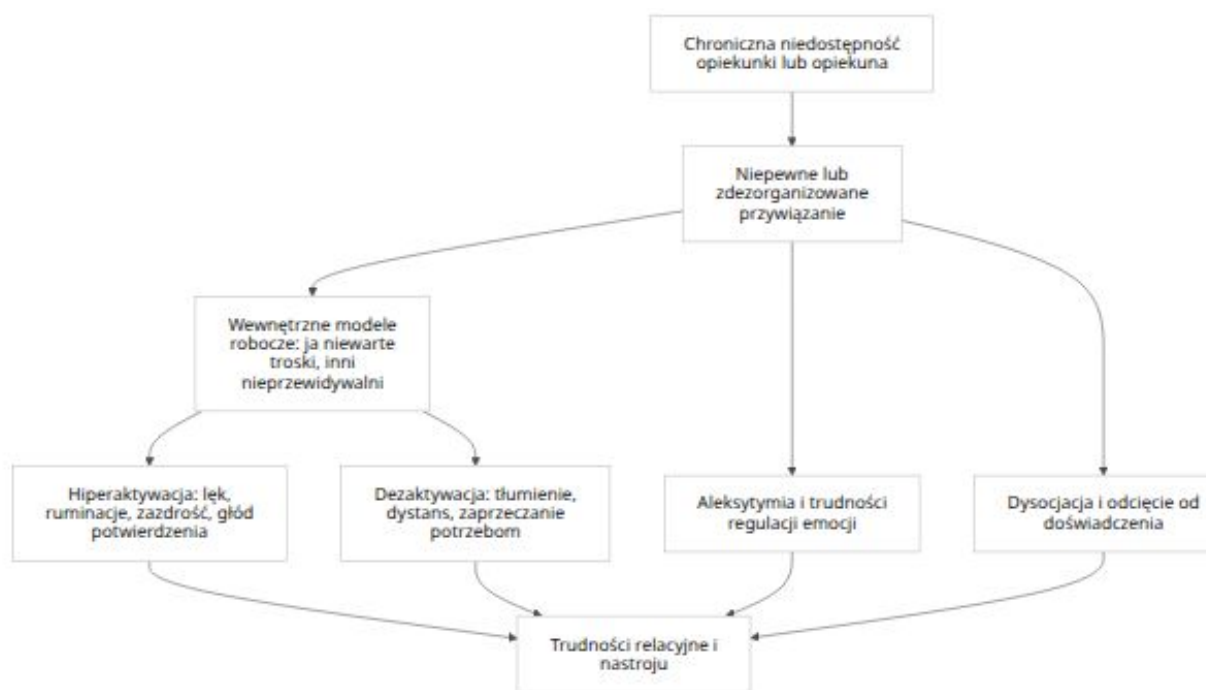


Diagram syntetyzuje najlepiej potwierdzone psychologiczne ścieżki: od deprivacji relacyjnej, przez niepewne przywiązanie i zaburzone modele robocze, do dysregulacji, dysocjacji i objawów klinicznych. [19]

Neurobiologiczne korelaty

Najlepiej udokumentowanym neurobiologicznym skutkiem wczesnej deprivacji i zaniedbania jest zmiana rozwoju sieci odpowiedzialnych za **regulację emocji, ocenę zagrożenia i kontrolę poznawczą**. Przeglądy wskazują na szczególną wrażliwość kory przedczołowej, hipokampa, ciała migdałowatego, połączeń istoty białej oraz systemów stresowych; trauma relacyjna w polskim piśmiennictwie jest opisywana jako przesunięcie układu nerwowego z orientacji na rozwój ku orientacji na przetrwanie. [20]

W badaniach strukturalnych nad **emocjonalnym maltretowaniem w dzieciństwie** van Harmelen i współpracownicy pokazali istotnie zmniejszoną objętość przyśrodkowej kory przedczołowej u dorosłych raportujących takie doświadczenia, a w późniejszej pracy tej samej grupy również hipoaktywność mPFC podczas kodowania i rozpoznawania bodźców emocjonalnych. To ważne, ponieważ mPFC jest kluczowa dla hamowania reakcji strachu, perspektywy autobiograficznej i odgórnej regulacji afektu. [21]

Badania nad deprivacją opieki pokazują równolegle nadreaktywność limbiczną. U młodzieży z historią deprivacji opiekuna i zaniedbania emocjonalnego

stwierdzano większą aktywację lewego ciała migdałowatego i przedniego hipokampa. W klasycznych badaniach nad późno adoptowanymi dziećmi po instytucjonalizacji późniejsza adopcja wiązała się z większą objętością amygdali, gorszą regulacją emocji i większym lękiem. [22]

Szczególnie silnym źródłem danych jest **Bucharest Early Intervention Project**. W tym programie dzieci wychowywane w instytucjach doznawały ubóstwa bodźców społecznych, emocjonalnych, językowych i poznawczych. Badania podłużne i przeglądowe wykazały niższą integralność istoty białej, mniejszą całkowitą objętość mózgu oraz zależne od czasu i interwencji różnice w rozwoju struktur limbicznych i korowych; równocześnie umieszczenie w dobrej pieczy zastępczej poprawiało część trajektorii rozwojowych, co jest mocnym argumentem za **neuroplastycznością** i znaczeniem korekcyjnej opieki. [23]

W zakresie osi **HPA** obraz jest bardziej złożony niż popularne stwierdzenie „trauma zawsze podwyższa kortyzol”. Nowsze przeglądy podkreślają, że wczesny stres może prowadzić zarówno do hiper-, jak i hiporeaktywności, zależnie od etapu rozwoju i rodzaju doświadczeń, natomiast metaanalityczne syntezy wskazują częściej na **spłaszczoną reaktywność stresową** niż na jednolity wzrost dobowego wydzielania. Wniosek praktyczny brzmi: u pacjentów z historią relacyjnego zaniedbania należy oczekiwać **dysregulacji**, a nie jednego prostego biomarkera. [24]

Na poziomie molekularnym dane są najbardziej przekonujące dla zmian dotyczących **glikokortykoidów, BDNF, układu serotonergicznego, dopaminergicznego i oksytocynowego**, ale pewność tych wniosków jest umiarkowana, bo duża część literatury ma charakter translacyjny lub pośredni. Przeglądy wskazują na epigenetyczne modyfikacje genów związanych z receptorem glikokortykoidowym, FKBP5 i BDNF, a także na długofalowy wpływ wczesnego stresu na sygnalizację oksytocyny, co może mieć znaczenie dla zachowań afiliacyjnych, zaufania i reakcji na bliskość. [25]

Poniższa tabela zbiera najważniejsze neurobiologiczne obserwacje.

Obszar	Najczęstszy wzorzec	Siła dowodów
mPFC	obniżona objętość lub aktywność po maltretowaniu emocjonalnym	umiarkowana do wysokiej [26]
Amygdala	większa reaktywność; w części badań większa objętość po deprywacji	umiarkowana [27]
Hipokamp	zmiany funkcjonalne i rozwojowe zależne od czasu ekspozycji	umiarkowana [28]

Obszar	Najczęstszy wzorzec	Siła dowodów
Istota biała	obniżona integralność po deprywacji instytucjonalnej	wysoka dla populacji silnie deprywowanych [29]
Oś HPA	dysregulacja; częściej spłaszczona reaktywność niż prosty wzrost kortyzolu	umiarkowana, heterogeniczna [30]
Neuroplastyczność	częściowa odwracalność dzięki poprawie jakości opieki i środowiska	umiarkowana do wysokiej [31]

Konsekwencje kliniczne i przymus powtarzania

Najsilniej udokumentowaną konsekwencją długotrwałego zaniedbania i maltretowania w dzieciństwie są zaburzenia nastroju. Duża metaanaliza Humphreys i wsp. wykazała, że wyższe nasilenie maltretowania dzieciństwa wiązało się zarówno z rozpoznaniem depresji, jak i z wyższymi objawami depresyjnymi; przeglądy kliniczne podkreślają, że wśród form krzywdzenia **emocjonalne nadużycia i zaniedbanie** należą do najsilniej związanych z późniejszą depresją. [32]

Równie trwałe są konsekwencje w sferze lęku, CPTSD i ogólnej dysregulacji. ICD-11 opisuje w CPTSD dodatkowe wobec PTSD zaburzenia samoregulacji: trudności w regulacji afektu, negatywny obraz siebie oraz problemy relacyjne. Ten profil dobrze odpowiada wielu dorosłym pacjentom z historią przewlekłego zaniedbania relacyjnego, nawet jeśli nie spełniają pełnych kryteriów CPTSD. [33]

W relacjach romantycznych skutki są zazwyczaj **małe do umiarkowanych na poziomie statystycznym, ale klinicznie przewlekłe**. Metaanaliza dotycząca maltretowania emocjonalnego i dobrostanu w związkach wykazała ujemny związek około $r = -0,143$, silniejszy dla negatywnych niż pozytywnych wymiarów relacji. Oznacza to, że historia zaniedbania nie „skazuje” na zły związek, ale przesuwą prawdopodobieństwo w kierunku niższego zaufania, mniejszej intymności, większej reaktywności i gorszej jakości relacji. [34]

Na poziomie tożsamości częste są: chroniczny wstyd, poczucie bycia „nie dość”, niestabilna samoocena, skłonność do nadmiernego przystosowania, trudności w wyznaczaniu granic oraz kłopoty z integracją autobiograficznego obrazu siebie. Metaanalizy i przeglądy dotyczące traumy rozwojowej pokazują związek między traumą a negatywnym self-concept, a badania nad dysocjacją podkreślają ryzyko fragmentacji doświadczenia i tożsamości. [35]

W funkcjonowaniu codziennym problem dotyczy nie tylko objawów, ale również pracy, nauki, rodzicielstwa, seksu, snu, korzystania ze wsparcia i zdolności do

współregulacji. NICE rozumie zdrowienie nie tylko jako redukcję objawów, lecz także jako odzyskanie **osobistego i społecznego funkcjonowania**, co jest szczególnie trafne u pacjentów z relacyjną traumą. [36]

Psychodynamiczny **przymus powtarzania** można rozumieć jako tendencję do nieświadomego odtwarzania znanych wzorców relacyjnych w nadziei na ich opanowanie lub „naprawienie”. W klasycznym ujęciu van der Kolk trauma może być powtarzana na poziomie zachowania, emocji, fizjologii i neuroendokrynnym, a współczesna literatura o reviktimizacji potwierdza, że doświadczenia przemocy i zaniedbania w dzieciństwie zwiększają ryzyko wejścia w dorosłości w relacje o podobnej jakości, zwłaszcza gdy pośredniczą w tym niepewne style przywiązania i wczesne schematy. [37]

Wybór partnera nie jest oczywiście prostym automatyzmem, ale **uzasadnioną inferencją** z danych jest to, że osoby z modelem „miłość = nieprzewidywalność / emocjonalna nieobecność / wysiłek bez ukojenia” częściej uznają takie sygnały za znajome i psychologicznie „czytelne”. Metaanalityczne związki między maltretowaniem a przywiązaniem lękowym i unikającym, a także gorszym dobrostanem w relacjach i reviktimizacją, dobrze wspierają tę interpretację, choć same badania nad stricte „wyborem partnera” są mniej jednoznaczne niż badania nad jakością relacji i stylem przywiązania. [38]



Protokół leczenia dla psychoterapeutów

Założenia ogólne

Leczenie „matczynej rany” nie powinno polegać na pracy z etykietą, lecz na **formulacji przypadku**: jaki był typ zaniedbania, jakie są dominujące objawy, jaki jest styl przywiązania, poziom dysocjacji, ryzyko samobójcze, stopień stabilności relacyjnej i czy występują rozpoznawalne zaburzenia współistniejące. W terapii traumy i depresji wytyczne zalecają dobór interwencji do obrazu klinicznego, preferencji pacjenta i poziomu nasilenia objawów, a w przypadkach złożonych uwzględnianie potrzeby struktury, monitorowania i współpracy między specjalistami. [39]

Cele terapeutyczne są zwykle cztery: **stabilizacja i bezpieczeństwo, przetworzenie pamięci relacyjnej/traumatycznej, przebudowa modeli roboczych oraz schematów**, a następnie **integracja tożsamości i zmiana wzorców relacyjnych w teraźniejszości**. U pacjentów z dużą dysocjacją, samouszkodzeniami albo aktywnym uzależnieniem leczenie zwykle wymaga dłuższej fazy stabilizacji przed intensywnym przetwarzaniem wspomnień. [40]

Model fazowy

Poniższa sekwencja integruje podejście zalecane przy złożonej traumie, praktykę terapii schematów oraz procedury traumy ukierunkowanej.

Faza	Główne zadania	Typowe techniki	Orientacyjny czas
Ocena i kontrakt	historia rozwojowa, mapa objawów, ryzyko, zasoby, cele	wywiad, psychoedukacja, pomiary bazowe, formułowanie przypadku	2–4 sesje [41]
Stabilizacja	bezpieczeństwo, sen, rytm dnia, uziemianie, tolerancja afektu, rozpoznawanie stanów	CBT-skills, grounding, praca oddechowa, interocepcja, plan kryzysowy, elementy DBT/ACT, ograniczona reedukacja relacyjna	4–12 sesji lub dłużej [42]
Przetwarzanie	integracja wspomnień i emocji, osłabienie intruzji, zmiana znaczeń	TF-CBT/CPT/PE, EMDR, imagery rescripting, chair work, narrative work	8–20+ sesji [43]
Integracja	nowe granice, wybory relacyjne, żałoba po „nieotrzymanym”, tożsamość, zapobieganie nawrotom	eksperymenty behawioralne, praca nad schematami, mentalizacja, relacyjne ekspozycje, plan nawrotu	6–12+ sesji [44]

Techniki zalecane i ich praktyczne miejsce

Terapia przywiązania w wersji attachment-informed jest najbardziej użyteczna jako **ramy terapeutycznej relacji**, a nie jako jedna, jednolita manualizowana metoda dla dorosłych. Oznacza to konsekwentne dostrajanie, nazywanie stanów umysłu, pracę nad współregulacją, analizę tego, jak pacjent przewiduje odpowiedź terapeuty, i ostrożne wykorzystywanie relacji terapeutycznej jako korektywnego doświadczenia. W leczeniu dorosłych z historią traumy przywiązaniowej evidence base jest bardziej pośrednia niż np. dla PTSD, ale znaczenie wzorców przywiązania dla przebiegu terapii i objawów jest dobrze potwierdzone. [45]

Terapia schematów jest szczególnie przydatna, gdy dominują: chroniczny wstyd, poczucie opuszczenia, deprywacja emocjonalna, podporządkowanie, samokrytycyzm, problemy osobowościowe lub utrwalone wzorce wybierania niedostępnych partnerów. Najbardziej charakterystyczne techniki to limited reparenting, imagery rescripting, chair work i praca z trybami. Systematyczne przeglądy wskazują na poprawę schematów i objawów, zwłaszcza w zaburzeniach osobowości i przewlekłych, złożonych prezentacjach klinicznych; baza dowodowa poza osobowością borderline jest rosnąca, ale bardziej nierówna. [46]

EMDR ma najsilniejsze zastosowanie wtedy, gdy pacjent ma dobrze określone wspomnienia rdzeniowe: bycie ignorowanym, zawstydzanym, porzucanym, przerażanym, nieutulonym lub świadkiem przemocy. W praktyce u pacjentów z „matczyną raną” targetami bywają zarówno sceny jawnie traumatyczne, jak i powtarzające się epizody emocjonalnego niebycia widzianym. Wytyczne NICE rekomendują EMDR jako leczenie PTSD po traumach niebojowych, a przeglądy pokazują redukcję objawów PTSD, depresji i lęku; w bardziej złożonych prezentacjach zwykle najlepiej działa po wcześniejszej stabilizacji. [47]

TF-CBT / CPT / PE / inne formy trauma-focused CBT są dobrym wyborem, gdy centralnym problemem są intruzje, unikanie, wstyd, poczucie winy, unikanie bliskości i katastroficzne znaczenia nadawane przeszłości. Ich siłą jest wysoka manualizacja, czytelna struktura i stosunkowo dobra przewidywalność procesu. U pacjentów z przewlekłą relacyjną traumą warto jednak zwolnić tempo i zwiększyć nacisk na stabilizację oraz powiązanie wniosków poznawczych z doświadczeniem ciała i relacji. [48]

Praca z ciałem może być użyteczna jako komponent stabilizacyjny: orienting, uziemienie, śledzenie napięcia, oddech, bezpieczny ruch, interocepcja, ćwiczenia tolerancji pobudzenia i wyciszenia. Dowody dla terapii body-based jako samodzielnego leczenia pierwszego wyboru są jeszcze ograniczone, ale przeglądy wskazują na wstępne korzyści dla objawów PTSD, afektu i dobrostanu. Najbezpieczniej traktować te metody jako **uzupełnienie**, nie substytut leczenia o silniejszej bazie dowodowej. [49]

Farmakoterapia nie leczy „matczynej rany” jako takiej, lecz może być bardzo potrzebna przy współistniejącej depresji, PTSD, zaburzeniach lękowych, bezsenności lub ciężkiej chwiejności afektywnej. NICE zaleca w PTSD rozważenie wenlafaksyny lub SSRI, np. sertraliny, gdy osoba preferuje leczenie farmakologiczne. W depresji o większym nasileniu zalecana jest kombinacja indywidualnej CBT i leku przeciwdepresyjnego; polskie wytyczne PTP zalecają ocenę skuteczności po 2–4 oraz 4–6 tygodniach i kontynuację leczenia zwykle

przez 6–9 miesięcy po remisji, a po wielokrotnych nawrotach dłużej. Trzeba też pamiętać, że historia traumy dziecięcej może średnio pogarszać odpowiedź na standardowe leczenie przeciwdepresyjne, choć wyniki nie są całkiem jednolite. [50]

Przykładowa sekwencja sesji

Sesja	Cel	Interwencja
Pierwsza	zbudowanie bezpieczeństwa i mapy problemu	wywiad rozwojowy, normalizacja reakcji, identyfikacja sytuacji wyzwalających, uzgodnienie celów i zasad
Czwarta	nauczenie współregulacji	skala pobudzenia 0–10, grounding, mapa sygnałów z ciała, plan na przeciążenie emocjonalne
Ósma	rozpoznanie rdzeniowego schematu	„co czuję, gdy proszę o bliskość?”, identyfikacja trybów: porzucone dziecko, zdyscyplinowany krytyk, odłączony obrońca
Dwunasta	korektywne doświadczenie wyobrażeniowe	imagery rescripting sceny ignorowania lub zawstydzenia przez matkę; dopisanie ochrony, nazwania i ukojenia
Szesnasta	przetwarzanie wspomnienia targetowego	EMDR lub trauma-focused reprocessing wokół obrazu, przekonania negatywnego i emocji towarzyszącej
Ostatnie	integracja i profilaktyka nawrotu	plan czerwonych flag, praca nad wyborem partnerów, granicami, stylem komunikacji i samowspółczuciem

Taka sekwencja jest **modelem przykładowym**, a nie sztywnym protokołem. U pacjentów z większą dysocjacją, aktywnym uzależnieniem lub przemocą domową potrzeba zwykle więcej stabilizacji; u pacjentów z wyraźnym PTSD po stabilnym okresie życia możliwe jest szybsze przejście do fazy przetwarzania. [51]

Narzędzia oceny i mierniki postępu

W praktyce warto monitorować pięć domen: **historię zaniedbania/traumy, przywiązanie, objawy depresji i lęku, objawy potraumatyczne oraz funkcjonowanie**. Użyteczny zestaw obejmuje: CTQ lub ACE do historii wczesnych doświadczeń, ECR-R do wymiarów przywiązania lękowego i unikającego, PHQ-9 i GAD-7 do objawów depresji i lęku, PCL-5 do nasilenia objawów PTSD oraz

WHODAS 2.0 do globalnego funkcjonowania. Przy dominujących trudnościach afektywnych można dodatkowo monitorować DERS i/lub TAS-20. [52]

Najbardziej klinicznie użytecznym wskaźnikiem postępu nie jest pojedynczy wynik w skali, lecz **konstelacja zmian**: mniejsza reaktywność na odrzucenie, większa zdolność proszenia o wsparcie, mniejsze unikanie, większa identyfikacja emocji, spadek samokrytycyzmu, lepszy sen, więcej elastyczności relacyjnej i poprawa funkcjonowania społecznego. NICE zaleca rutynowe monitorowanie wyników sesyjnych przy użyciu walidowanych narzędzi. [36]

Przeciwwskazania i ryzyka

Najważniejsze ryzyko polega na **zbyt szybkim wejściu w przetwarzanie traumy** u pacjenta, który nie potrafi wrócić do okna tolerancji. Może to nasilić dysocjację, autodestrukcję, chaos relacyjny i poczucie porzucenia przez terapeutę, jeśli terapia zostaje potem przerwana lub spowolniona bez dobrego wyjaśnienia. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy wysokiej dysocjacji, aktywnych samouszkodzeniach, dużym ryzyku samobójczym, psychozie, epizodzie maniakalnym, ciężkich zaburzeniach używania substancji oraz trwającej przemocy w bliskiej relacji. [53]

W pracy z tą grupą pacjentów raczej należy unikać **jednorazowego „katharsis bez kontenera”**, czyli gwałtownego wydobywania bolesnych wspomnień bez wcześniejszego nauczania regulacji i bez planu integracji. NICE wprost odradza psychologicznie ukierunkowany debriefing w profilaktyce i leczeniu PTSD, a wytyczne depresji przypominają, że fokus na bolesnych relacjach rodzinnych może początkowo zwiększać dystres. [54]

Tabele porównawcze metod terapeutycznych

Poniższa tabela porównuje najważniejsze podejścia, które realnie można wykorzystać u dorosłych pacjentów z obrazem „matczynej rany”. To nie jest ranking „najlepszej” terapii, lecz porównanie **wskazań i jakości dowodów**.

Metoda	Kiedy szczególnie wskazana	Główne cele	Typowy czas	Stan dowodów	Ograniczenia i ryzyka
Trauma-focus ed CBT / CPT / PE	wyraźne objawy PTSD, unikanie, poczucie winy/wstydu, intruzje	przetworzenie traumy, zmiana znaczeń, redukcja unikania	zwykle 8–12 sesji, dłużej przy wielokrotnym traumie [55]	wysoki dla PTSD; umiarkowany dla bardziej złożonych prezentacji [56]	wymaga gotowości do ekspozycji; przy dużej dysocjacji potrzebuje wolniejszego tempa

Metoda	Kiedy szczególnie wskazana	Główne cele	Typowy czas	Stan dowodów	Ograniczenia i ryzyka
EMDR	wspomnienia rdzeniowe, obrazy relacyjne, somatyczne „zamrożenie”, gdy pacjent słabiej toleruje długą narracyjną ekspozycję	rekonsolidacja pamięci, osłabienie obciążenia afektywnego	zwykle kilkanaście sesji; często dłużej w złożonej traumie [57]	wysoki dla PTSD niebojowego; umiarkowany dla CPTSD i objawów współistniejących [58]	zbyt szybkie targetowanie może destabilizować; wymaga dobrej oceny zasobów
Terapia schematów	chroniczny wstyd, deprywacja emocjonalna, porzucenie, samokrytycyzm, cechy osobowościowe, powtarzanie wzorców relacyjnych	zmiana schematów i trybów, doświadczenie korektywne, integracja potrzeb	zwykle średnio- lub długoterminowa	umiarkowany do wysokiego dla zaburzeń osobowości; umiarkowany i rosnący w innych populacjach [59]	wolniejsza, zasobochłonna; wymaga dobrej pracy z granicami i zależnością
Podejście attachment-informed	lęk przed zależnością, trudności z zaufaniem, silne reaktywacje w relacji terapeutycznej	współregulacja, mentalizacja, korekta modeli roboczych, bezpieczna relacja	zwykle średnio- lub długoterminowa	umiarkowany pośredni; jako jednolita metoda u dorosłych dowody słabsze [60]	ryzyko rozmycia celu terapii, jeśli brak struktury i monitoringu objawów
Praca z ciałem	wysoka somatyzacja, odcięcie od sygnałów ciała, przeciążenie autonomiczne	uziemiające, tolerancja pobudzenia, interocepcja, odzyskanie poczucia sprawstwa	zwykle komponent w tle całego procesu	niski do umiarkowanego jako monoterapii; lepiej wsparta jako dodatek [61]	nie powinna zastępować leczenia traumy o silniejszej bazie dowodowej
Farmakoterapia	większa depresja, PTSD z nasilonym lękiem/bezsennością, brak możliwości pełnego udziału w psychoterapii	redukcja objawów osiowych i ułatwienie udziału w terapii	miesiące do lat, zależnie od epizodu i nawrotowości	wysoki dla depresji umiarkowanej/ciężkiej i PTSD w wybranych lekach [62]	nie zmienia sama z siebie wzorców przywiązania; możliwe działania niepożądane,

Metoda	Kiedy szczególnie wskazana	Główne cele	Typowy czas	Stan dowodów	Ograniczenia i ryzyka
					problem odstawienia

Druga tabela porządkuje krótkie decyzje kliniczne „jeżeli–to”.

Obraz dominujący	Pierwszy wybór	Drugi krok
PTSD/CPTSD z intruzjami i unikaniem	TF-CBT lub EMDR po stabilizacji [63]	dołączenie pracy schematowej/relacyjnej przy utrwalonych wzorcach
Chroniczny wstyd, pustka, „nigdy nie byłam widziana”	terapia schematów + attachment-informed stance [64]	EMDR/imagery rescripting dla rdzeniowych scen
Depresja umiarkowana lub ciężka	CBT + lek przeciwdepresyjny [65]	rozszerzenie o pracę nad traumą po poprawie stabilności
Duża dysocjacja i rozregulowanie	stabilizacja, grounding, praca z ciałem, struktura i bezpieczeństwo [66]	dopiero później przetwarzanie wspomnień
Powtarzanie dysfunkcyjnych relacji	terapia schematów / attachment-informed + eksperymenty behawioralne [67]	EMDR dla pamięci korelujących z wyborem partnera

Streszczenie dowodów i stopień pewności wniosków

Najwyższą pewność mają wnioski, że **wczesne zaniedbanie emocjonalne i inne formy maltretowania** zwiększają ryzyko depresji, lęku, CPTSD, aleksytymii, odrzuceniowrażliwości i trudności w relacjach. Te zależności potwierdzają metaanalizy i duże przeglądy systematyczne. Wysoka jest też pewność, że poprawa jakości opieki i bezpieczna relacja terapeutyczna mogą częściowo modyfikować trajektorię rozwoju, co wspiera ideę plastyczności zamiast determinizmu. [68]

Średnią pewność mają wnioski neurobiologiczne. Mamy dobre dane dla kory przedczołowej, amygdali i istoty białej, zwłaszcza przy ciężkiej depriwacji, ale słabszą zgodność dla osi HPA i dla specyficznych układów neuroprzekaznikowych. Wiele badań neurobiologicznych jest obserwacyjnych, o małych próbach, z retrospektywną oceną doświadczeń, a część wyników zależy od wieku, płci, czasu ekspozycji i współistniejącej psychopatologii. [69]

Średnią do wysokiej pewności mają wnioski terapeutyczne dla PTSD i depresji: trauma-focused psychotherapies oraz EMDR są dobrze wspierane w PTSD,

a w cięższej depresji zasadne jest łączenie CBT z farmakoterapią. Dla złożonych następstw relacyjnych i osobowościowych terapia schematów jest obiecująca i coraz lepiej udokumentowana, ale nie ma jeszcze tak jednolitej bazy RCT jak klasyczne terapie PTSD. Dla pracy z ciałem dowody pozostają wstępne; dla „attachment-based therapy” u dorosłych lepiej mówić o **podejściu przywiązaniowym** niż o jednej, silnie zwalidowanej metodzie. [70]

Największa niepewność dotyczy pytań, które brzmią bardzo intuicyjnie, ale są metodologicznie trudne: czy istnieje neurobiologicznie lub klinicznie swoisty „efekt matki” odrębny od ogólnej jakości opieki, jaki dokładnie jest mechanizm wyboru partnerów w dorosłości oraz które komponenty terapii są najważniejsze dla zmiany wzorców przywiązaniowych. Aktualny stan wiedzy sugeruje, że najbezpieczniej jest traktować „matczyną ranę” jako **metaforę kliniczną dla relacyjnego deficytu we wczesnym rozwoju**, a leczenie planować na podstawie konkretnych objawów, schematów i funkcji zachowań. [71]

Wniosek	Stopień pewności
Wczesne zaniedbanie emocjonalne zwiększa ryzyko depresji i trudności relacyjnych	wysoki [72]
Niepewne przywiązanie i aleksytymia są ważnymi mediatorami	umiarkowany do wysokiego [73]
Istnieją trwałe zmiany w mPFC, amygdali i istocie białej	umiarkowany [74]
Oś HPA jest zaburzona, ale nie w jeden prosty sposób	umiarkowany [75]
EMDR i TF-CBT są skuteczne w osi PTSD	wysoki [76]
Terapia schematów jest bardzo użyteczna przy chronicznych wzorcach relacyjnych	umiarkowany [77]
Praca z ciałem jest pomocna jako dodatek, ale nie jako samodzielny złoty standard	niski do umiarkowanego [61]

Najkrótsza praktyczna synteza dla psychoterapeuty: nie leczyć „rany” jako sloganu; leczyć **depresję, PTSD/CPTSD, schemat deprywacji emocjonalnej, dysocjację, unikanie bliskości, lęk przywiązaniowy i deficyty regulacji** — w tej kolejności i z takim tempem, na jakie pozwala aktualne bezpieczeństwo pacjenta. [78]

[1] <https://icd.who.int/>

<https://icd.who.int/>

[2] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7589986/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7589986/>

[3] [14] [19] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5600283/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5600283/>

[4] [41] [43] [47] [48] [50] [54] [55] [57] [62] [63] [70] [76]

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/chapter/recommendations>

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/chapter/recommendations>

[5] <https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-156722-112492?filename=112492.pdf>

<https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-156722-112492?filename=112492.pdf>

[6] [71] <https://www.repository.cam.ac.uk/items/f9bc667c-2c2b-4a4e-a725-51916fddfb7e>

<https://www.repository.cam.ac.uk/items/f9bc667c-2c2b-4a4e-a725-51916fddfb7e>

[7] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8205446/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8205446/>

[8] [11] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2724169/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2724169/>

[9] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4516809/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4516809/>

[10] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25622303/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25622303/>

[12] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7476782/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7476782/>

[13] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8607343/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8607343/>

[15] [38]
https://www.researchgate.net/publication/408178081_Childhood_Maltreatment_and_Adult_Attachment_A_Three-Level_Meta-Analytic_Review
https://www.researchgate.net/publication/408178081_Childhood_Maltreatment_and_Adult_Attachment_A_Three-Level_Meta-Analytic_Review

[16] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10849076/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10849076/>

[17] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37261746/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37261746/>

[18] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7678681/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7678681/>

[20] [24] [30] [75] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9120425/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9120425/>

[21] [26] [69] [74] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20692648/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20692648/>

[22] [27] [28] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2926942/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2926942/>

[23] [29] [31] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4413892/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4413892/>

[25] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7503815/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7503815/>

[32] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062423/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062423/>

[33] <https://link.springer.com/article/10.1186/s40479-021-00148-8>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s40479-021-00148-8>

[34] [67] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524838020975895?mi=ehikzz&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound&utm_medium=referral&utm_source=researcher_app
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524838020975895?mi=ehikzz&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound&utm_medium=referral&utm_source=researcher_app

[35] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920440/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920440/>

[36] [65] <https://www.nice.org.uk/guidance/ng222/chapter/recommendations>
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng222/chapter/recommendations>

[37] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2664732/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2664732/>

[39] [78] <https://www.apa.org/ptsd-guideline>
<https://www.apa.org/ptsd-guideline>

[40] <https://www.apa.org/practice/guidelines/adults-complex-trauma-histories.pdf>
<https://www.apa.org/practice/guidelines/adults-complex-trauma-histories.pdf>

[42] [51] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11035878/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11035878/>

[44] [46] [59] [64] [77] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5573974/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5573974/>

[45] [60] <https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/foc.8.1.foc127>
<https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/foc.8.1.foc127>

[49] [61] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6973294/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6973294/>

[52] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5798009/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5798009/>

[53] [66] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9162402/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9162402/>

[56] <https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments>
<https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments>

[58] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5904704/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5904704/>

[68] [72] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7081433/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7081433/>

[73] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36700354/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36700354/>